



DESARROLLO FISICO Y PSIQUICO DE LOS NINOS PRODUCTOS DE UN EMBARAZO DE MADRES CON ANTECEDENTES DE VIOLENCIA PRECOZ. UN ESTUDIO LONGITUDINAL DE NINOS EN LIMA, PERU

Investigador principal: Bizu Gelaye, PhD

Co-Investigadores: Sixto E. Sánchez, Martha Rondón,

PROBLEMA

La violencia contra las mujeres es un problema de salud pública persistente y difundida en todo el mundo. En un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en varios países la prevalencia de vida reportada de violencia sexual o física por la pareja sexual varió entre 15% y 71%. De los 15 países estudiados en este estudio, Lima, Perú tuvo una tasa elevada de prevalencia de vida de violencia física por la pareja (48,6%) y de violencia sexual por la pareja (22,5%) ¹.

La violencia por el compañero íntimo (VCI) afecta por largo plazo la salud física y mental de las mujeres. La VCI aumenta el riesgo de la mujer para presentar migraña, ansiedad, depresión y abuso de alcohol o drogas ². El embarazo se caracteriza por profundos cambios hormonales y las mujeres son más susceptibles a los cambios de humor y los trastornos de ansiedad durante este tiempo. Estudios previos, incluyendo la primera cohorte PrOMIS (IRB22215), realizado en el Instituto Materno Perinatal por nuestro equipo de investigación, han demostrado asociaciones entre la historia de abuso y el estado de ánimo / ansiedad / depresión y estrés y los problemas crónicos del sueño durante el embarazo ^{3,4}. VCI también aumenta el riesgo de una mujer de desarrollar complicaciones del embarazo incluyendo bajo al nacer peso, parto prematuro y muerte neonatal ^{2,4-6}. El abuso infantil es otro problema de salud pública frecuente y urgente. El costo colectivo de maltrato infantil en los países de ingresos bajos y medianos ha sido estimada en alrededor de USD \$ 3.594 millones de dólares, anualmente ⁷. Para las personas expuestas, el abuso también deteriora todos los aspectos del desarrollo, incluyendo problemas físicos, sociales y psicológicos. Se puede desarrollar daños considerable por haber experimentado abuso y puede tener efectos nocivos a través de todo el ciclo de la vida ⁸⁻¹², incluyendo menarquia temprana ^{13,14}, inflamación ¹⁵ sistémica crónica, riesgo de dificultades en el desarrollo, inseguridad o problemas de relación con los demás, exacerbación del sentimiento de miedo, estrategias de supervivencia negativas y comportamientos suicidas ^{12,16}.

Estudios previos han seguido cohortes de recién nacidos para evaluar la salud de la madre durante el embarazo, y los resultados de la salud materna a largo plazo y el desarrollo de los infantes ¹⁷⁻²⁰. Pocos estudios, sin embargo, han evaluado exhaustivamente los efectos a largo plazo del abuso infantil y de la violencia de género por el compañero sexual y el estado de ánimo / trastornos de ansiedad en las madres y sus hijos. Hasta donde sabemos, no se ha investigado previamente entre mujeres de bajos ingresos la relación entre la alta prevalencia de VCI y el abuso infantil.

Justificación de la investigación.

Este estudio proporcionará nueva información que ayudará a avanzar en nuestra comprensión de la relación entre la violencia de pareja y la salud materna infantil. El estudio examinará los mecanismos por los que la violencia y los problemas de salud mental pueden tener efectos a largo plazo sobre la madre y el niño. A partir de este estudio, podrían surgir información etiológica causal y mecanicista sobre los trastornos depresivos y trastornos de ansiedad. La comprensión de los efectos intergeneracionales a largo plazo de las experiencias maternas de abuso infantil y VCI sobre los resultados en la salud infantil, permitirá el desarrollo de estrategias para el diseño de programas de intervención y prevención para las mujeres embarazadas y sus hijos.



OBJETIVO GENERAL

Proporcionar información de seguimiento de la violencia precoz y durante el embarazo por el compañero sexual y su relación con efectos a largo plazo sobre el estado de salud mental de las mujeres y la salud y el desarrollo del niño resultante.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Objetivo Específico # 1: Evaluar el grado en que la exposición materna a la violencia precoz, incluyendo el abuso durante la niñez y la experiencia de la violencia por el compañero sexual (VCI) están asociados con el crecimiento infantil, parámetros del desarrollo infantil, y su desarrollo físico.

Objetivo Específico # 2: Evaluar el grado en que la exposición maternal a la violencia precoz, incluyendo el abuso durante la niñez y las experiencias de violencia por el compañero sexual están asociados con el desarrollo conductual y cognitivo de sus niños

Objetivo Específico # 3: Examinar el grado en que el apoyo social y las medidas de resiliencia atenúan las influencias de las experiencias traumáticas maternas sobre los resultados de los niños resultantes.

Objetivo Específico #4: Evaluar el nivel de stress crónico experimentado por 2000 participantes del estudio de cohortes realizado entre el 2012 y el 2016 que hayan o no experimentado VCI, a través del nivel de cortisol en el cabello. El nivel de estrés de las pacientes está directamente relacionado al nivel de cortisol en el cabello. La hipótesis es que las mujeres con problemas de violencia de género tienen mayor nivel de stress, medido a través del cortisol contenido en el cabello.

Objetivo Específico #5: Evaluar el nivel de stress crónico experimentado por 2000 niños participantes cuyas madres hayan o no experimentado VCI, a través del nivel de cortisol en el cabello. La hipótesis es que los niños nacidos de mujeres con problemas de violencia de género tienen mayor nivel de stress, medido a través del cortisol contenido en el cabello.

METODOS

Diseño del estudio: Estudio de cohorte longitudinal prospectivo en madres y niños que han participado en un estudio previo de cohortes. Este estudio, el cual aún se encuentra en su fase final se llama: “Estudio de Cohorte para identificar la asociación entre el abuso por el compañero sexual, estado de ánimo y trastorno de ansiedad y el desarrollo de parto pre término. Este estudio, el cual se encuentra en su fase final incluye aproximadamente 4.000 mujeres reclutadas durante su control prenatal en el INMP.

Institución de estudio: El instituto Materno perinatal atiende aproximadamente 18,000 a 20,000 pacientes nuevos cada año. El INMP se dedica a la atención materna y perinatal sobre todo para las mujeres de bajos ingresos en Lima. Las características de esta institución representan una excelente oportunidad para que los investigadores hayan realizado el seguimiento de las mujeres reclutadas en el estudio de Cohortes PrOMIS. Este estudio ha sido realizado por aproximadamente 4 años en esta misma institución y su objetivo fue el encontrar la asociación entre el parto pre término y el antecedente de violencia de género, estrés y desordenes del ánimo.



Tiempo del estudio: Julio 2020 – Junio 2025. Estamos planificando hacer un seguimiento de los niños cada dos años por aproximadamente 15 años

Número de participantes: Se ha calculado un total de 2000 mujeres que participaron en el estudio previo de cohortes mencionado

Criterios de Inclusión:

Mujeres de 18 a 49 años participantes del estudio de cohorte previo
Incluidas antes de las 16 semanas en su embarazo ultimo
Atendidas en el INMPN durante su control prenatal
Tuvieron su parto de un recién nacido vivo el cual ya tiene 3 años o más
Expresaron su deseo de ser contactados en futuros estudios
Capaces de leer y escribir en castellano,

Criterios de exclusión

Parto ultimo con recién nacido muerto
Problemas mentales de la madre

Criterios de exclusión usados en el estudio previo de cohortes:

< de 18 o > 49 años
CPN después de las 16 semanas
Déficit mental
Embarazo múltiple
Feto con malformaciones estructurales
Incapacidad para comunicarse en castellano
Historia de hipertensión gestacional crónica diabetes mellitus, sepsis, síndrome antifosfolipídico, enfermedad renal

Variables del estudio:

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:

Variable	Tipo	Indicador	Categorías	Medición de las categorías
Violencia por el compañero sexual (VCSI)	Cualitativa	instrumento de violencia contra la mujer de la OMS	Emocional Física No	Respuestas afirmativa a una de las preguntas 1 o de la 5 a la 13 Respuesta afirmativa a pregunta 2, 3 o 4
Estrés materno	Cualitativa	Ficha de recolección de datos, nivel de cortisol en el cabello	Si No	Respuesta afirmativa a una de las preguntas que exploran estos eventos Cortisol en cabello > 20ug/cm
Esfuerzo físico materno	Cuantitativa	Ficha de recolección de datos		Número de horas de ejercicio fuerte durante los últimos 6-9 meses

Consumo materno de Café	Cuantitativa	Ficha de recolección de datos	Si No	Numero de tasas de café tomadas durante últimos 6-9 meses
Consumo materno de alcohol	Cuantitativa	Ficha de recolección de datos	Si No	Numero de tragos de alcohol tomados durante últimos 6-9 meses
Depresión materna	Cualitativa	Test de depresión PHQ-9	Moderada a severa Mínima o leve	Puntaje: 10 o mas Puntaje: 9 o menos
Soporte social	Cualitativa	Cuestionario de soporte social	Adecuado Inadecuado	
Estrés post traumático	Cualitativa	PTSD Lista de chequeo_Ver sion civil	Si No	Puntaje > 100 Puntaje de 100 o menos
Resiliencia	Cualitativa	Escala de Connor-Davidson	Adecuada No adecuada	20 o mas puntos < de 20 puntos
Problema de sueño en madre o niño	Cualitativa	Indice de Pittsburgh	Si No	Puntaje: 10 o mas Puntaje 9 o menos
Crecimiento del niño	Cualitativa	Medidas antropométricas	Normal Anormal	
Estrés en niño	Cualitativa	Ficha de recolección de datos, nivel de cortisol en el cabello	Si No	Respuesta afirmativa a una de las preguntas que exploran estos eventos Cortisol en cabello > 20ug/cm

Procedimientos del estudio

Identificación de participantes, reclutamiento y tamizaje: Entrevistadoras capacitadas utilizarán un guion telefónico (ver adjunto) para ponerse en contacto con las potenciales participantes del estudio entre aquellas participantes que tomaron parte en el estudio de cohortes de violencia/parto pre término y que cumplan los criterios de inclusión. Las entrevistadoras determinarán el interés de las pacientes en participar del estudio. Solo entonces procederá con las preguntas de tamizaje. Como parte del reclutamiento y tamizaje, las potenciales participantes elegibles serán informadas de algunas preguntas personales que se les hará durante el proceso de la entrevista.

Entrevista y medidas antropométricas:

Todas las participantes del estudio (n = 2.000) completarán una entrevista después de su enrolamiento en el estudio. La entrevista puede tomar hasta una hora y media e incluirá sub escalas para evaluar estilos de vida y síntomas del estado de ánimo materno. El cuestionario también incluirá preguntas sobre la salud de los hijos y



aspectos importantes de su desarrollo. Las entrevistadoras también tomarán las medidas antropométricas de las participantes, incluyendo talla, peso, presión arterial, y las circunferencias de: brazo, cuello y muslo. Las participantes pueden descansar en cualquier momento durante la entrevista.

Obtención de muestra de cabello:

Después de terminar la entrevista estructurada, se obtendrá una muestra de cabello. Las participantes pueden negarse a dar esta muestra. El contenido de cortisol en el cabello proporciona una adecuada monitorización de la liberación de cortisol durante un período prolongado de tiempo y no requiere mayor manipulación ni almacenamiento especial; evitando problemas metodológicos asociados con la obtención de otras muestras para medir el cortisol tales como el plasma o la orina. La obtención de cabello es indolora y no invasiva y será realizada por enfermeras entrenadas. Nuestro equipo de investigación ha demostrado viabilidad y aceptabilidad de la obtención de muestras de cabello en diversas poblaciones de estudio tales como en Boston, Chile, y Perú.

Revisión de registros médicos: Se revisará los registros médicos de las participantes y sus niños con la finalidad de recopilar información detallada sobre sus características clínicas. Los registros médicos serán revisados después del consentimiento. Los datos a obtener a partir de los registros médicos incluyen información detallada sobre las características cardiovasculares, neurológicas y clínicas. Los registros médicos se utilizarán para determinar la información que no se obtiene fácilmente a partir de entrevistas. En el caso en que los niños se controlen en otras instituciones, se obtendrán la información después de haber obtenido la aprobación de estas instituciones

Métodos de reclutamiento:

Como se señaló anteriormente, entrevistadoras entrenadas se contactarán telefónicamente usando un guion con las potenciales participantes, las cuales formaron parte del Estudio de Cohorte que tuvo por objeto identificar la relación entre parto pre término y el abuso por el compañero sexual, estado de ánimo y los trastornos de ansiedad materna. Las entrevistadoras determinarán el interés de las pacientes en participar en una nueva entrevista y los datos de seguimiento a recoger longitudinalmente. Se permitirá a las mujeres elegir si desea continuar con el proceso de selección. Si de acuerdo al proceso de selección una mujer es considerada no elegible para el estudio, la entrevistadora le informará que el estudio no es una buena opción para ella por el momento y terminará el proceso de reclutamiento. Si la potencial participante está interesada en participar será invitada a venir al IMPN coincidiendo con una visita de control del niño en un día y hora conveniente para ella y su niño. Alternativamente, si el niño se controla en otro establecimiento de salud, iremos hacia tal institución para la entrevista.

Vamos a mantener un registro que contenga información de cuántas mujeres fueron seleccionados, cuántas fueron elegibles, y cuántas no eran elegibles y la razón de esto

Plan de análisis estadístico de los datos

La base de datos conteniendo información no identificable será transferida electrónicamente desde Lima a Boston. Las entrevistadoras y los administradores del proyecto revisarán los datos recolectados de la entrevista para asegurar el control de calidad antes que los datos sean ingresados en la base de datos electrónica

El análisis será realizado usando SPSS. Se hará un análisis standard de proporciones y variables continuas. Todos los resultados serán reportados en forma agregada y no individualmente.

De acuerdo a lo apropiado, se hará análisis de subgrupos y técnicas multivariadas para identificar la relación entre las experiencias maternas de abuso y las características más importantes del desarrollo del niño. El análisis incluirá todos los sujetos de investigación. (N=2,000)

ASPECTOS ETICOS



Aprobación del estudio: Este estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Harvard (se adjunta aprobación) y seguidamente se solicitará la aprobación del Comité de Ética del INMPN.

Protección de los derechos y el bienestar de los participantes

Para minimizar la potencial coerción o la aparente coerción, todo el personal de la investigación recibirá un entrenamiento en los procedimientos apropiados para participantes en investigación. Los proveedores de salud, tales como los médicos no estarán involucrados en el reclutamiento ni el proceso de consentimiento y se consultará a las enfermeras que apoyan al médico para asegurar que las pacientes puedan ser invitadas a participar en el estudio.

La protección contra los riesgos se inicia teniendo un equipo experimentado de investigadores quienes han trabajado con mujeres incluyendo aquellas con historia de exposición a violencia y continua con el entrenamiento cuidadoso y supervisión del staff de la investigación. Los Dres Gelaye, Sánchez, Rondón y la Sra. Sanchez tienen gran experiencia conduciendo investigación en mujeres víctimas de violencia y entrenarán al personal de la investigación en aspectos de seguridad acerca del abuso durante todo el Proyecto. Los Dres Williams y Sánchez están terminando un estudio patrocinado por el NIH que incluye sobrevivientes a violencia de género. El entrenamiento incluye la sensibilización a las experiencias de las sobrevivientes al abuso, así como en depresión y consentimiento informado. Todo el personal de la investigación ha recibido entrenamiento en conducta ética y procedimientos apropiados de la investigación en humanos y en este nuevo estudio, todos los miembros del equipo de investigación (administrativos y personal técnico así como también como las trabajadora sociales) recibirán entrenamiento en aspectos éticos y en aspectos relacionados a los procedimientos del proyecto antes de su inicio. Aseguraremos que todos los miembros del equipo comprendan el propósito del estudio, por qué se usan medidas especiales, y otros aspectos éticos de la investigación, tales como el respeto, beneficencia y confidencialidad. Los objetivos del entrenamiento incluirán el apoyo al staff para que desarrollen una comprensión completa de los objetivos del Proyecto de investigación y ayudarlas a familiarizarse con el cuestionario y el protocolo de investigación. Adicionalmente, se capacitará a las trabajadoras sociales sobre las técnicas de entrevista y como seguir las guías de seguridad y normas éticas durante la ejecución del estudio.

Proceso de consentimiento

Las entrevistadoras informarán a las participantes que su participación y de su niño en este estudio es completamente voluntario y también sobre el proceso de consentimiento informado y que ellas tendrán la opción de no participar, que son libres de retirarse en cualquier momento, y que tienen la opción de rehusar a responder a cualquier pregunta o a algún examen o toma de muestra del cabello, sin ninguna penalidad para ella o su bebé en el cuidado médico que recibirán en la institución. Solo aquellas que están deseosas de participar en el estudio firmarán el consentimiento informado

Se les dará suficiente tiempo para revisar el formato consentimiento y preguntar cualquier pregunta del estudio para asegurar que entiende lo que significa su participación en el estudio.

Para ser consistentes con el estudio de cohortes previo, las mismas trabajadoras sociales capacitadas llevarán a cabo el proceso del consentimiento informado escrito antes de la aplicación de la entrevista creada para este estudio en un ambiente que asegure privacidad.

Obtención de una muestra de cabello del niño

Se solicitará el permiso de las madres para obtener una muestra de cabello y hacer las mediciones antropométricas de los niños. Los niños incluidos en el estudio tienen entre 3 a 8 años de edad.

Riesgos



Somos conscientes que las sobrevivientes del abuso y la potencial depresión hacen que esta población sea extremadamente vulnerable. Sentimos sin embargo que nuestros esfuerzos para proveer protección adecuada, combinada con la necesidad de mejorar la salud de la madre y sus niños, justifica el riesgo potencial. Los riesgos potenciales para las participantes incluyen la falta de confidencialidad, cansancio y estrés debido a la naturaleza de algunas de las preguntas. Existe un protocolo en el lugar para las participantes que necesitan intervención o asistencia. La entrevistadora recibirá entrenamiento específico acerca de las preguntas de salud mental que serán preguntadas y referirá a las participantes cuando sea necesario. La paciente será referida para hablar con la psicóloga del hospital para recibir consejería. Esta referencia será cubierta por su seguro de salud y es parte del cuidado que recibiría de cualquier manera en el hospital y ella no incurrirá en costos adicionales por estos servicios.

La obtención de las medidas antropométricas y de una muestra de cabello son no invasivas e indoloras y serán recolectadas por personal entrenado del estudio. Nuestro grupo ha demostrado que es posible y aceptable la colección de la muestra de cabello en grupos diversos del estudio.

Confidencialidad

La falta de confidencialidad es un riesgo potencial, sin embargo ninguna información obtenida debe colocar a las participantes en riesgo de responsabilidad civil o penal o alguna desventaja financiera, capacidad de trabajar o reputación.

Las participantes serán informadas acerca de la confidencialidad de la información. Alguna de la información obtenida será de naturaleza personal y las participantes podrían no sentirse confortables respondiendo. Los formatos de consentimiento informado, lista de las participantes al estudio y todas las copia impresas del estudio con los datos obtenidos serán archivados y almacenados en vitrinas cerradas y en ambientes cerrados con chapa. Solo el personal de la investigación tendrá acceso a estos datos. Todos los datos recolectados serán confidenciales y no existirá manera de asociarlos a la identificación de las participantes.

Minimización del riesgo:

Minimizaremos el potencial riesgo de falta de confidencialidad guardando los formatos de datos y los materiales de estudio en vitrinas cerradas y con llave en ambientes cerrados y con llave y usando los datos sin identificación personal. Solo el personal de investigación tendrá acceso a los datos. Para los cuestionarios/entrevistas, las participantes pueden dejar de responder algunas preguntas que no les haga sentir bien. Adicionalmente, se reiterará a las participantes que pueden elegir retirarse del estudio en cualquier momento

Beneficios

Existe una posibilidad de que las mujeres puedan beneficiarse de la información de referencia que se les brinde en respuesta a haber referido angustia. Aparte de esto y los beneficios psicológicos y del conocimiento que estarán ayudando a la investigación perinatal, no existirá beneficios directos de la participación en el estudio

En el estudio se han desarrollado estrategias para manejar potenciales problemas relacionados al estrés.

Las trabajadora sociales entrevistadoras tienen experiencia referir a participantes víctimas de violencia de género a las instancias pertinentes, incluyendo instituciones que ofrecen apoyo psicológico, legal, consejería, defensa legal y apoyo social. Esta información será ofrecida a las participantes del estudio en una tarjeta impresa. Previamente, antes que la acepte, se preguntará a las participantes si es seguro que reciban esta tarjeta, la cual incluye información de otras instituciones de salud.



En el Perú, existen leyes para reportar al área de psicología del hospital el abuso sexual si es identificado por profesionales de salud. El instituto Nacional Materno Perinatal, “La Maternidad”, tiene un programa de prevención de violencia que incluye un tamizaje para detectar el abuso en todas las pacientes. Estos mecanismos han sido implementados in situ para establecer un procedimiento estándar para identificar el abuso en mujeres. Si durante la entrevista, la madre refiere abuso actualmente, de acuerdo a los protocolos del hospital, la entrevistadora la referirá a psicología para que maneje el caso. La ley peruana no requiere el reporte obligatorio de los casos de abuso sexual a alguna institución policial o de servicio social.

Potenciales beneficios a la comunidad/sociedad

El objetivo de este estudio es proveer información de seguimiento acerca de los efectos a largo plazo de la violencia por el compañero sexual durante el embarazo en relación a la salud mental a largo plazo y la salud y desarrollo de sus niños. Este estudio proveerá información nueva que ayudará a avanzar nuestra comprensión de la relación existente entre la violencia por el compañero sexual y la salud materna y de su niño. El estudio examinará los mecanismos por los cuales la violencia y la mala salud mental pueda tener efectos a largo plazo tanto en la madre como el niño. La información etiológica y mecanística acerca de los desórdenes depresivos y de ansiedad de la madre y el niño podrían emerger de este estudio. La comprensión a largo plazo y los efectos intergeneracionales de las experiencias maternas del abuso sexual y violencia infantil permitirá desarrollar estrategias para diseñar intervenciones y programas de prevención para mujeres embarazadas y sus niños. Pocos estudios han evaluado en su totalidad los efectos a largo plazo del abuso infantil, de la violencia por el compañero sexual y de los desórdenes del ánimo/ansiedad en las madres y sus niños. En nuestro conocimiento, ningún estudio ha investigado la relación entre mujeres de bajos recursos en comunidades con gran prevalencia de violencia por el compañero sexual y abuso infantil. Por lo tanto, es sustancial los beneficios que se obtendrán para otras mujeres en cualquier país.

Eventos adversos

La posibilidad de eventos adversos relacionados a los procedimientos del estudio es improbable. En caso que exista algún evento adverso o evento adverso serio, reportaremos tales eventos a la Oficina de Asuntos Regulatorios y de Conformidad de la investigación dentro de 5 días y al Comité de Ética del IMPN.

Daños relacionados al estudio

No existe

Privacidad de las participantes

Para este estudio, todas las entrevistas de las participantes serán hechas en ambientes privados con un aviso “No Interrumpir” colocado en la parte externa de la puerta para asegurar la privacidad y que nadie entre durante la sesión. Si una mujer está acompañada por algún miembro de la familia o amistad, solo la mujer entrará al ambiente privado para la entrevista. En este estudio, las entrevistadoras trabajarán en pares. Una entrevistadora conduce la entrevista con la participante en el ambiente privado y otra entrevistadora puede hablar con el familiar o amistad explicando de la necesidad de privacidad y que esto es una práctica de rutina. La persona acompañante no tendrá conocimiento de la naturaleza de la investigación.

Tiempo de almacenamiento de los datos

Los formatos de consentimiento y las copias impresas de los datos del estudio serán archivados y almacenados en vitrinas y cuartos con chapa. Los datos obtenidos no contendrán ninguna identificación, solo un código. Solo el personal de la investigación tendrá acceso a vincular los códigos con la identificación de las participantes. Todos los datos obtenidos serán guardados confidencialmente. La información recogida de las participantes será compilada, analizadas y presentadas como información agregada de las participantes. Después que el estudio ha completado, los formatos de consentimiento informado y otros datos del estudio serán archivados y almacenados en vitrinas cerradas con chapa por 7 años o en computadoras protegidas con un password. Después del final del



estudio y cuando se complete la auditoria de los datos, los archivos de datos que vinculan los códigos del estudio al nombre de las participantes serán destruidos.

Acceso a la información de las participantes

Solo los miembros del equipo de investigación tendrán acceso a la información de las participantes. Una obstetriz revisará las historias clínicas de la madre y el niño para recolectar información de sus resultados obstétricos y perinatales

Futuro uso de los datos

La información recogida de las participantes será compilada, analizada y presentada como un agregado de información de los individuos. Los reportes que se hagan del estudio no tendrán información que pueda identificar a los sujetos

Pagos.

No habrá ningún pago a las pacientes, excepto por el transporte usado para venir al establecimiento y regresar a su domicilio. Si la paciente lo prefiere, se le proveerá una tarjeta del Metro o del Metropolitano, equivalente a 33 soles. Se brindará esta tarjeta al final de la entrevista. Si, por alguna razón, una mujer decide detener la entrevista en cualquier momento, de todas maneras se proporcionará esta tarjeta.

Diseminación de los resultados de la investigación

Los resultados agregados de este estudio serán diseminados entre los profesionales de salud en el Perú. Los hallazgos y sus implicancias serán discutidos con las autoridades de salud y otros involucrados. Para diseminar la información obtenida, se harán los esfuerzos en publicar los hallazgos en alguna revista médica regional o internacional indexada

Medidas para manejar los aspectos regulatorios y de conformidad del estudio

El nombre de la paciente y su firma estarán impresos en los consentimientos informados. Los formatos de consentimiento serán archivados y almacenados en vitrinas con llave y cuartos con llave. Las participantes también nos proveerán información de contacto para su seguimiento de tal manera que se les hará llamadas para recordar las citas (dentro de dos días si la participante desea que se complete la entrevista algún tiempo después). Al final del estudio, cuando todos los datos sean auditados, se destruirá el archivo auditado de los datos que vinculan los códigos de las participantes a su identificación. Anticipamos que la auditoria final de los datos será el 31 de Diciembre del 2035, y que los vínculos entre los registros del estudio serán destruidos después de esa fecha. Todos los datos, especímenes biológicos y la información de contacto para el seguimiento, recolectados durante el proceso de evaluación serán guardados en vitrinas con llave en la oficina del supervisor de campo en Lima. Los archivos electrónicos serán guardados con códigos protegidos. Las entrevistas impresas y las bases de datos electrónicas identificarán a los participantes solo por código, no por nombre. Solo el personal del estudio tendrá acceso a estas entrevistas impresas y a las bases electrónicas de datos. Todos los reportes o publicaciones que se hagan mostrarán los datos agregados y no existirá ninguna información que pueda ser usada para identificar a las participantes. Destruiremos toda identificación personal al final del proyecto. Las presentaciones o artículos tampoco incluirán identificación de las participantes. El administrador del programa, Dr. Sixto Sánchez será la única persona que tendrá acceso a la información que permite vincular los datos con los nombres de las participantes y tendrá la facultad de destruirlos después del 31 de Diciembre del 2035.

PERSONAL RESPONSABLE.-

Aquí una descripción de los investigadores.



Bizu Gelaye, PhD, MPH, Investigador principal, es profesor de epidemiólogo de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Sus estudios incluyen una integración de los marcadores biológicos y moleculares dentro de estudios clínicos y comunitarios en los aspectos perinatales, cardio metabólicos y neuropsiquiátricos. Él tiene gran experiencia mundial en el diseño, ejecución y análisis de estudios clínicos y comunitarios de estudios epidemiológicos de biomarcadores clínicos. El recibió su grado de Maestría y PhD en epidemiología en la Universidad de Washington, Seattle, USA. Las investigaciones del Dr. Gelaye incluyen: 1) Desórdenes neuropsiquiátricos en desórdenes de la salud mental perinatal, 2) Marcadores biológicos en estudios comunitarios para identificar factores que contribuyen a la resiliencia y el riesgo de desórdenes neuropsiquiátricos, 3) Aplicación de métodos epidemiológicos avanzados y métodos estadísticos en investigación psicométrica, y 4) epidemiología de enfermedades crónicas no comunicables a nivel mundial. Él tiene mucha experiencia en el diseño y ejecución de estudios poblacionales a gran escala basados en estudios epidemiológicos de biomarcadores en África Su-Sahariana y en Sud América. El Dr. Gelaye es también director del programa de entrenamiento de minorías en investigación internacional en salud, programa que inició en la Universidad de Washington. Este es un programa nacional creado por el NIMHD, para proveer oportunidades de investigación (en una perspectiva internacional) para estudiantes graduados y de pre grado de grupos tradicionalmente poco representados en la especialidad de investigación.

Archana Basu, PhD, co-investigador, es investigadora asociada en Harvard TH Chan School of Public Health e instructora en Massachusetts General Hospital / Harvard Medical School. La Dra. Basu tiene más de 15 años de investigación centrada en el trauma y experiencia clínica trabajando con niños y familias, realizando investigaciones observacionales y clínicas.

Elizabeth Levey MD, co-investigador, es psiquiatra infantil en el Hospital General de Massachusetts. Actualmente está colaborando con el Dr. Gelaye, Dr. Sanchez y los investigadores peruanos en un premio NIMH K23 en Perú centrado en el trauma.

Dra. Marta B. Rondón, MD, MSc (Co-Investigador, Investigadora principal local). Profesor Asistente de Psiquiatría en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es consultora del Instituto Nacional Materno Perinatal, donde brinda atención psiquiátrica a mujeres embarazadas y adolescentes. Fue la primera mujer Presidenta de la Asociación Psiquiátrica Peruana y primera mujer Vicedecana del Colegio de Médicos del Perú. Ha llevado a cabo una amplia investigación sobre la salud mental de las mujeres en el Perú y en toda América Latina, con un enfoque en el período perinatal. Ha sido mentora de varios estudiantes de maestría y doctorado en investigación clínica, cuantitativa y epidemiológica.

Sixto E. Sánchez, MD, MPH, Co-Investigador, es profesor de Salud Pública e Investigación en la Universidad San Martín de Porres. Él ha colaborado con el equipo de la Universidad de Harvard desde 1996. Él ha colaborado en varios estudios patrocinados por el NIH, incluyendo uno titulado: Un estudio de cohortes de parto pre-término en relación a la violencia de género, ansiedad y desórdenes del ánimo. Adicionalmente es autor o coautor de más de 40 publicaciones y presentaciones, él ha sido mentor de estudiantes que han trabajado en proyectos que buscan el riesgo de desórdenes psiquiátricos y desórdenes del sueño.

El Dr. Gelaye, investigador principal coordinará estrechamente tendrá reuniones regulares de coordinación con los miembros del equipo del estudio acerca del progreso de la investigación para asegurar que la investigación termine satisfactoriamente con un gran nivel de calidad. Adicionalmente, el Dr. Gelaye se comunicará semanalmente, vía teléfono o Skype e emails con el personal del estudio en Perú. El personal del estudio recibirá directivas y actividades necesarias de manera regular.

El personal del estudio recibirá entrenamiento en los diferentes procedimientos del estudio antes del inicio del estudio.



El Dr. Bizu Gelaye más de 16 años de experiencia conduciendo investigación en Lima, Perú con el Dr. Sixto Sánchez y están familiarizados con la cultura local

Sra. Elena Sánchez, Administradora de estudios con más de 15 años de experiencia manejando investigación clínica en Lima, Perú. Ella ha administrado exitosamente más de 10 proyectos y ha entrenado y supervisado al personal de las investigaciones dentro de su posición como administradora de proyectos en Lima. La Sra. Elena Sánchez es peruana

Entrevistadoras del estudio: Incluye trabajadoras sociales y psicólogas quienes tienen gran experiencia trabajando en proyectos de investigación clínica que incluyen mujeres embarazadas y mujeres con problemas de violencia por el compañero sexual. Una obstetra realiza todas las mediciones antropométricas y la presión arterial en el estudio.

Referencias:

1. Garcia-Moreno C, Jansen HAFM, Ellsberg M, Heise L, Watts CH. Prevalence of intimate partner violence: findings from the WHO multi-country study on women's health and domestic violence. *The Lancet*. 2006;368:1260-1269.
2. Sarkar NN. The impact of intimate partner violence on women's reproductive health and pregnancy outcome. *J Obstet Gynaecol*. 2008;28:266-271.
3. Barrios YV, Gelaye B, Zhong Q, *et al*. Association of childhood physical and sexual abuse with intimate partner violence, poor general health and depressive symptoms among pregnant women. *PLoS One*. 2015;10:e0116609.
4. Cripe SM, Sanchez SE, Gelaye B, Sanchez E, Williams MA. Association between intimate partner violence, migraine and probable migraine. *Headache*. 2011;51:208-219.
5. Sanchez SE, Alva AV, Diez Chang G, *et al*. Risk of spontaneous preterm birth in relation to maternal exposure to intimate partner violence during pregnancy in Peru. *Matern Child Health J*. 2013;17:485-492.
6. Barrios YV, Sanchez SE, Qiu C, Gelaye B, Williams MA. Risk of spontaneous preterm birth in relation to maternal experience of serious life events during pregnancy. *Int J Womens Health*. 2014;6:249-257.
7. Fearon J, Hoeffler A. Benefits and Costs of the Conflict and Violence Targets for the Post-2015 Development Agenda: Post-2015 Consensus. In. *Copenhagen Consensus Center*; 2014.
8. Sachs-Ericsson N, Blazer D, Plant EA, Arnow B. Childhood sexual and physical abuse and the 1-year prevalence of medical problems in the National Comorbidity Survey. *Health Psychol*. 2005;24:32-40.
9. Danese A, Moffitt TE, Harrington H, *et al*. Adverse childhood experiences and adult risk factors for age-related disease: depression, inflammation, and clustering of metabolic risk markers. *Arch Pediatr Adolesc Med*. 2009;163:1135-1143.



10. Fang X, Brown DS, Florence CS, Mercy JA. The economic burden of child maltreatment in the United States and implications for prevention. *Child Abuse & Neglect*. 2012;36:156-165.
11. Dube SR, Fairweather D, Pearson WS, Felitti VJ, Anda RF, Croft JB. Cumulative childhood stress and autoimmune diseases in adults. *Psychosom Med*. 2009;71:243-250.
12. Dube S, Anda R, Felitti V, Chapman D, Williamson D, Giles W. Childhood abuse, household dysfunction, and the risk of attempted suicide throughout the life span: findings from the Adverse Childhood Experiences Study. *JAMA*. 2001;286:3089-3096.
13. Barrios YV, Sanchez SE, Nicolaidis C, *et al*. Childhood abuse and early menarche among Peruvian women. *Journal of Adolescent Health*. 2015;56:197-202.
14. Wise LA, Palmer JR, Rothman EF, Rosenberg L. Childhood abuse and early menarche: findings from the black women's health study. *Am J Public Health*. 2009;99 Suppl 2:S460-466.
15. Bertone-Johnson ER, Whitcomb BW, Missmer SA, Karlson EW, Rich-Edwards JW. Inflammation and early-life abuse in women. *Am J Prev Med*. 2012;43:611-620.
16. Coogan PF, Wise LA, O'Connor GT, Brown TA, Palmer JR, Rosenberg L. Abuse during childhood and adolescence and risk of adult-onset asthma in African American women. *J Allergy Clin Immunol*. 2013;131:1058-1063.
17. Boyd A, Golding J, Macleod J, *et al*. Cohort Profile: the 'children of the 90s'--the index offspring of the Avon Longitudinal Study of Parents and Children. *Int J Epidemiol*. 2013;42:111-127.
18. Victora CG, Hallal PC, Araujo CL, Menezes AM, Wells JC, Barros FC. Cohort profile: the 1993 Pelotas (Brazil) birth cohort study. *Int J Epidemiol*. 2008;37:704-709.
19. Victora CG, Barros FC. Cohort profile: the 1982 Pelotas (Brazil) birth cohort study. *Int J Epidemiol*. 2006;35:237-242.
20. Oken E, Baccarelli AA, Gold DR, *et al*. Cohort profile: project viva. *Int J Epidemiol*. 2015;44:37-48.